

Derivación cutánea continente (bolsa de Indiana)

WARWIKI

Información para el paciente · Una bolsa interna que vacía con una sonda — sin bolsa externa

Una derivación cutánea continente es una bolsa interna hecha con su propio intestino que almacena la orina dentro del cuerpo, con una pequeña abertura a prueba de fugas (un estoma, a menudo oculto en el ombligo). En vez de usar una bolsa externa, vacía la bolsa pasando una sonda por la abertura varias veces al día. La bolsa de Indiana es la versión más común.

Acerca de este procedimiento

Se usa un trozo de **intestino grueso y delgado** para formar un **reservorio** de baja presión dentro del abdomen; los uréteres (tubos de los riñones) drenan en él. Un canal corto con una **válvula de un solo sentido** se lleva a la piel — a menudo el **ombligo** — como un estoma pequeño y plano que queda seco entre cateterismos.

- Pasa una sonda para vaciar la bolsa cada **4–6 horas**.
- **Lava (irriga)** la bolsa para limpiar el moco.
- **Sin bolsa externa** — solo una gasa o apósito sobre el estoma.

Es una buena opción para quienes no quieren bolsa externa, no son candidatos a (o prefieren no tener) una neovejiga, y pueden **cateterizar de forma confiable** — lo cual requiere buen pulso y vista, o un cuidador que ayude.

¿Es seguro?

Es una opción continente bien establecida. Es una operación más grande y larga que un conducto, y requiere cateterizar de por vida. Los riesgos incluyen los de la cirugía (sangrado, infección, fuga), dificultad para pasar la sonda o estrechez o fuga del estoma (a veces requiere un retoque), cálculos en la bolsa, moco, infecciones de orina, y cambios de sales/vitaminas/riñón a largo plazo que se vigilan en el seguimiento.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Derivación continente

Un sistema urinario a prueba de fugas — usted controla cuándo se vacía.

Bolsa de Indiana

La bolsa continente más común, hecha de colon derecho e intestino delgado.

Reservorio (bolsa)

El saco interno, hecho de intestino, que guarda la orina.

Estoma

La pequeña abertura en la piel (a menudo el ombligo) por la que pasa la sonda.

Cateterizar

Pasar un tubo delgado por el estoma para vaciar la bolsa.

Irrigar

Lavar la bolsa con agua para limpiar el moco.

Uréteres

Los tubos que llevan la orina desde los riñones; drenan en la bolsa.

Moco

Líquido resbaladizo que produce el intestino; limpiarlo es parte del cuidado.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general, así que no siente nada durante ella. Después, espere molestia abdominal, y el intestino tarda unos días en “despertar”. Despierta con un tubo en la bolsa (más sondas blandas) que queda unas 3–4 semanas mientras sana — usted lo lava para limpiar el moco. La mayoría permanece en el hospital unos 5–8 días.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general** — siga todas las instrucciones (ayuno, suspenda anticoagulantes como le indiquen). Puede tener una **preparación intestinal**.
- Su equipo planea el **sitio del estoma** (a menudo el ombligo) y confirma que usted — o un cuidador — puede manejar el **cateterismo de por vida**.
- **No fume**, y organice ayuda en casa para después.

Avisé a su equipo con antelación si usted:

- Toma un **anticoagulante**, o tiene una infección actual
- Tiene **enfermedad intestinal**, problemas de riñón, o alguna dificultad de **mano o vista** que afecte el cateterismo

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Está dormido con anestesia y se administran antibióticos.
- 2 Se aparta un trozo de intestino y el resto se reconecta.
- 3 El intestino se reforma en una bolsa, y un canal cateterizable con válvula de un solo sentido se lleva a la piel como estoma.
- 4 Se conectan los uréteres; se colocan un tubo en la bolsa y sondas blandas mientras sana.

Después de la cirugía

- Va a casa en unos **5–8 días** con el **tubo de la bolsa ~3–4 semanas**; lávelo con regularidad para limpiar el moco.
- Tras retirarlo y sanar la bolsa, **cateteriza el estoma cada 4–6 horas** e irriga para limpiar el moco.
- El estoma queda **seco** — lo cubre una gasa o apósito (sin bolsa externa).
- El moco es normal; tome líquidos; seguimiento de por vida (vitamina B12, controles de la bolsa). **Evite cargar peso ~6 semanas**.

Llame a su equipo o busque atención de inmediato si usted:

- **No puede pasar la sonda o no sale orina** — la bolsa puede sobrellenarse y debe vaciarse con urgencia
- Tiene fiebre o escalofríos
- Tiene dolor abdominal intenso, vómitos, o **no expulsa gases ni heces**
- Tiene sangrado abundante o coágulos que tapan la sonda, o enrojecimiento o secreción de la herida

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La bolsa cutánea continente (de Indiana) almacena la orina dentro de usted, con una pequeña abertura a prueba de fugas que vacía con sonda — sin bolsa externa.
2. Cateterizará el estoma cada 4–6 horas y lo lavará para limpiar el moco, de por vida — por eso importan el pulso y la vista (o un ayudante).
3. Prepárese con ayuno y preparación intestinal, no fume, y organice ayuda. Busque atención urgente si alguna vez no puede pasar la sonda o no sale orina.